

Demorar

Imc -

INDICADO POR: Dr. Carolina
(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JORGE MARTINS DE SOUZA

IDADE: 74	PESO: 77	ALTURA: 170	PROFISSÃO: Represent. Comercial
SINTOMAS: Despertares noturnos / Fadiga mm ^h			
QUEIXAS: Boca ressecada e Insônia			
MEDICAMENTOS: Propofol / Lanotidam / Zelozor			
MÉDICO: Dr. Carolina			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: fisioterapia			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S		ALMOÇO: S	LANCHE: S JANTAR: S
HORA QUE DORME: 22		HORA QUE ACORDA: 00:00	
COCHILHO (X) S () N 1h	DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE esposa		
TEM FILHOS: () S () N	DORMEM NO QUARTO: () S () N		PET NO QUARTO: () S () N
BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N a vezes			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 2 a 3X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ↑ levemente		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III	IAH: 27.4	SPO2: 81% / Despert
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Parkinson / Eficiência sono 60% / 12.6/h			
3 stents → cardíaco			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: —			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA	() OUTROS: esquecimento	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N		SPO2 CI/CPAP:	PRESSÃO NO EXAME: —
23/05 - Avaliação			
25			

30/05/25 P= 6-12 cmH₂O 95-mediana
116 percentil
IAH= 30,6 elh
mundo: 4h 91
fluxo: 27,4 l/min matachela

09/06/25 P= 9,6 cmH₂O P90: 11,8 cmH₂O
IAH= 25,6 elh Desc: 14,3 elh Ao: 10 elh
mundo: 4 horas } o sono menor
fluxo 37 l/min Silveira } dormindo lateral

23/06 P= 8,5 cmH₂O P90: 10,8 cmH₂O
20/5 IAH= 11 elh Ao: 9 mundo 7d / 13d → gripado
mundo: 3 horas sente difícil de manter o sono.
fluxo: 26 l/min

* ficou apneico pelo Philips*
Auto B à 11 cmH₂O.

PR: 90 cmH₂O

Silveira

20/06
20/05

→ sentiu bem o Aparelho.
iniciou medicação sono
outras higienizadas

10/07
25

P=8,1 cmHg

TAH=19,1 e LA

med. uso: 4h 591

Tentativa de contato Online s/ sucesso
17 de uso 120

Matilda

18/07
25

Pmed: 7,9

TAH=22,8 e LA

med. uso: 2h 56

fluido: 2min

Recumbente 11 cmHg

te. 11

10.13

lip. 2,5

queixa de ficar sem ver
no foguete exp.

Deixou P fixa: 8,5 cmHg.

25/07

Tentei contato pelo whats s/ sucesso

Ass



End. Rua Colômbia, 162 - Jardim das Nações
Taubaté-SP CEP: 12086-530
Tel: (12) 33631.2142
Whats: (12) 99703-3463

20/3

15,30

28/3 08h10

Relatório do Exame de Polissonografia

Nome: JORGE MARTINS DE SOUZA

Idade: 72 anos

Sexo: Masculino

Peso: 84 kg

Altura: 1,70 m

RAO: 29,07

Data do Exame: 04-03-2024

Médico solicitante: DRA DENISE LANZONI DE ALVARENGA

COMENTÁRIOS:

Exame realizado 04/03/2024 20:59 horas e encerrado 05/03/2024 04:51 horas, com latência para o sono de 6,8 minutos e teste para o sono REM de 52,6 minutos. O tempo total do registro foi de 478,7 minutos, com eficiência do sono de 58,5%. A distribuição dos estágios do sono foi:

Estágio do sono	% encontrada	% previsto*
Estágio 1	8,7%	AM 5%
Estágio 2	73,5%	45 - 55%
Estágio 3	9,2%	> 15%
Sono REM	8,6%	20 - 25%
Eficiência do sono	58,5%	> 85%

*Durante o período total de registro, o(a) paciente permaneceu 186,0 minutos acordado(a) e ocorreram 72 despertares (índice de despertar 12,6/hora).

*Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71,9 bpm, a maior de 250 bpm e a menor de 65 bpm.

*Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

*O número total de eventos respiratórios apresentados foi 131, sendo 35 apnéias (0 central, 36 obstrutivas e 0 mista), 93 hipopnéias e 0 "RERAs". O índice de apnéia-hipopnéia total foi 27,4/hora, sendo 8,0 apnéia/hora e 19,5 hipopnéia/hora. O índice de apnéia-hipopnéia no sono REM foi 39,2/hora, sendo 22,0 apnéia/hora e 17,1 hipopnéia/hora. O índice de distúrbio respiratório foi 27,4/hora. Ocorreram 0 RERAs com tempo médio de 0 segundos, com duração máxima de 0 segundos e índice de 0,0h.

*A saturação basal de oxihemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 81%, permanecendo 2,6 minutos com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 147 dessaturações.

*Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

SB (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA.

Conclusão

1. Eficiência do sono reduzida;
2. Redução da porcentagem do sono REM e do sono de ondas lentas;
3. Latência para início do sono e para início do sono REM normal;
4. Aumento moderado do índice de apnéia-hipopnéia (IAH = 27,4/hora);
5. Índice de despertares aumentado (Índice de despertar = 12,6/hora);
6. Dessaturação da ox-hemoglobina associada aos eventos respiratórios;
7. Presença de roncos.

DENISE
LANZONI DE
ALVARENGA
20990180816

Assinado de forma
digital por DENISE
LANZONI DE
ALVARENGA, 20990
180816
Data: 2024.03.12
16:55:09 -03'00'

Dra. Denise L. Alvarenga
CRM: 98997

Otorrinolaringologista e Médica de Sono

Paciente: JORGE MARTINS DE SOUZA
Data do exame: 04-03-2024

Página 1 de 7